IMSS

Dirección de Prestaciones Médicas

Coordinación de Proyectos Especiales en salud

Guía Operativa para la Respuesta ante Incidentes Intencionales con Múltiples Víctimas

Directorio

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Dirección General

Dr. Jorge Gaviño Ambriz
Secretaría General

Dra. Alva Alejandra Santos Carrillo
Dirección de Prestaciones Médicas

Dr. Mauricio Hernández Ávila
Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

Mtro. Borsalino González Andrade
Dirección de Administración

Lic. Luisa Obrador Garrido Cuesta
Dirección de Incorporación y Recaudación

Mtra. Norma Gabriela López Castañeda
Dirección Jurídica

Mtra. Claudia Laura Vázquez Espinoza
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Mtro. Marco Aurelio Ramírez Corzo
Dirección de Finanzas

Lic. Javier Guerrero García
Dirección de Operación y Evaluación

Mtro. Arturo De Lucio Ortega
Dirección de Planeación para la Transformación Institucional

Dra. Janett Alvarado González
Coordinación de Proyectos Especiales en Salud

Este documento fue elaborado por la **Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS,** atiende las recomendaciones de los ítems 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71 y 72 del Índice de Seguridad Hospitalaria de la Organización Panamericana de la Salud e incorpora recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y mejores prácticas basadas en la evidencia sobre atención a eventos Intencionales con múltiples víctimas.

Es responsabilidad de cada establecimiento de salud adaptar las recomendaciones aquí vertidas, considerando sus capacidades, recursos, nivel de atención, análisis de riesgos y condiciones particulares, bajo el criterio técnico y profesional del personal responsable, priorizando la seguridad de pacientes, personal y la continuidad de los servicios.

Derechos reservados © 2026
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos patrimoniales.

Índice

Directorio 1
1. Objeto, alcance y definiciones 4
2. Principios generales de actuación 5
3. Procedimiento operativo ante el alertamiento de evento intencional 6
3.1 Aspectos clave en cada fase 7
3.2 Activación operativa (aplicable a TODOS los escenarios) 7
Paso 1. Recepción de alerta y verificación 7
Paso 2. Activación del Plan de Contingencia para Arribo Masivo de Víctimas 8
Paso 3. Seguridad física inmediata 8
Paso 4. Activar, señalizar y comunicar: 9
Paso 5. Triaje y manejo inicial 10
Paso 6. Comunicación interna y externa 10
Paso 7. Primeros auxilios psicológicos y gestión posterior 11
4. Anexos 12
Anexo 1. Diagrama de flujo de la activación operativa (aplicable a todos los escenarios) 12
Anexo 2. Pacientes afectados por agentes químicos 13
Flujograma del anexo 3. Pacientes afectados por agentes radiológicos / nucleares 15
Anexo 4. Lesionados por explosivos 16
Flujograma del anexo 4. Lesionados por explosivos 17
Anexo 5. Tirador activo (Active Shooter) en o cerca del hospital 18
Flujograma del anexo 5. Tirador activo (Active Shooter) en o cerca del hospital 21
Referencias 22
Recursos 23
Contacto 24

1. Objetivo

Establecer un procedimiento operativo estándar para que los establecimientos de salud del IMSS, de todos los niveles de atención, respondan, de forma segura y coordinada al arribo de pacientes derivados de:

1. Explosiones intencionales o sospecha de **artefactos explosivos**.
2. Exposición a agentes químicos.
3. Exposición a agentes radiológicos o nucleares.
4. Incidentes con **tirador activo / atacante armado** tanto al interior de la unidad médica o en sus inmediaciones.
5. Incluir respuesta a ciberataques o incidentes intencionales que afecten sistemas de salud, como ransomware (cifrado y secuestro de datos) en registros médicos.

Ámbito de aplicación. Aplica a todos los establecimientos de salud de primero, segundo y tercer nivel, unidades complementarias y sus servicios críticos (urgencias, hospitalización, terapia intensiva, tococirugía, quirófanos, laboratorio, entre otros).

Se articula con el Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres, el Programa Interno de Protección Civil y los Planes específicos o de contingencia.

Definiciones clave:

- **Incidente intencional con múltiples víctimas (IIMV):** Evento súbito, generalmente de origen humano deliberado, que genera un número de víctimas que puede superar la capacidad habitual de un Establecimiento de Salud.
- **QBRNE:** Eventos químicos (Q), radiológicos/nucleares (RN) y Explosivos (E) que generan víctimas; los biológicos (B) se manejan en guías específicas, por lo que se omitirá en este documento, agregando la letra “E” para referirnos a explosivo.
- **Tirador activo:** Individuo que está “activamente involucrado en matar” o intentar matar al máximo número de personas en un área poblada y confinada.
- **Ciberincidente intencional:** Ataque digital deliberado, como hacking o DDoS, que interrumpe operaciones críticas en salud.
- **Violencia Armada:** amenaza de uso o exhibición de armas de fuego u otras armas letales por parte de una o varias personas dentro de un establecimiento de salud, con fines criminales o intimidatorios, dirigidos a una o varias personas.
- **CVOED:** Es el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres, administrado por la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas.

- **Sistema de Comando de Incidentes para Establecimientos de Salud (SCI-H)** es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional común con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento o incidente.

2. Principios generales de actuación

1. **Primero la seguridad del personal.** Ningún paciente se beneficia si el personal operativo del establecimiento de salud se convierte en víctima. Nadie entra en zonas potencialmente contaminadas o inseguras, sin equipo de protección y sin confirmación de seguridad por parte de las autoridades competentes.
2. **Exposición, distancia y blindaje.** En el proceso de atención a eventos QBRNE, es fundamental aplicar los conceptos de reducción del tiempo de exposición, establecimiento de distancias adecuadas para la atención, adecuada disposición de ropa contaminada y la implementación de mecanismos de protección para el personal como el uso de dosímetros, equipo de protección personal EPP, chalecos plomados, entre otros).
3. **Mando único y coordinación interinstitucional.** Uso de un Sistema de Comando de Incidentes para Establecimientos de Salud (SCI-H) u organización similar, alineado con protección civil, seguridad pública, servicios de emergencia y autoridades, además de comunicación con agencias que apoyan la gestión de incidentes QBRNE.
4. **Continuidad operativa del establecimiento de salud.** Proteger y mantener las funciones de las áreas críticas tanto para la atención de pacientes como para el funcionamiento de la unidad (urgencias, terapia intensiva, quirófanos, banco de sangre, sistemas de información, suministros energéticos y medicinales) con el fin de limitar un número mayor de víctimas
5. **Enfoque ALARA:** (as low as reasonably achievable)**.** La magnitud de las dosis individuales (tiempo), el número de personas expuestas (personal de salud), y la posibilidad de las exposiciones deben mantenerse tan bajas como sea razonablemente alcanzable. .
6. **Atención a grupos vulnerables.** Considerar desde el diseño del procedimiento, el flujo para niños, embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad y con barreras de comunicación o movilidad.
7. **Comunicación clara y en lenguaje sencillo.** Evitar códigos incomprensibles para el público en mensajes críticos (usar texto plano además de códigos internos).
8. **Comunicación e información oficial.** Durante este tipo de eventos, resulta crucial establecer vías de comunicación oficial que informen de manera clara la evolución y el desarrollo del proceso de atención, evitando así el daño colateral que puede generar la desinformación, se puede establecer un sitio en la periferia del establecimiento de salud con un censo de pacientes actualizado para atención de familiares (capacidad de informar

estado de salud o referencia a otra unidad médica. Mantener comunicación a través de las herramientas del sistema CVOED.

9. **Aprendizaje y mejora continua.** Implica realizar entrenamientos periódicos, llevar a cabo simulacros (incluidos ejercicios de escritorio, funcionales y de despliegue) y actualizar los procedimientos después de cada evento real o práctica, con el fin de fortalecer de manera continua la capacidad de respuesta.
10. **Soporte psicosocial integrado.** Incluir atención inmediata a trauma psicológico para víctimas y personal, con protocolos basados en la OMS.

3. Procedimiento operativo ante el alertamiento de evento intencional

El presente procedimiento organiza la respuesta hospitalaria en tres fases operativas: antes, durante y después del incidente. Cada fase establece acciones operativas para garantizar la seguridad del personal, la continuidad de la atención y el manejo eficaz del arribo masivo de pacientes derivados de eventos intencionales o QBRNE, considerando escenarios híbridos como ataques físicos con componentes cibernéticos.

3.1 Responsables operativos mínimos por función (SCI-H)

Para asegurar una respuesta oportuna, coordinada y sin ambigüedades durante las primeras fases del incidente, cada establecimiento de salud deberá identificar previamente a los responsables operativos por función, conforme a la estructura del Sistema de Comando de Incidentes para Establecimientos de Salud (SCI-H):

- Comando: Director(a) del establecimiento de salud o su suplente designado.
- Operaciones: Jefatura de Urgencias y Enfermería líder del turno.
- Logística: Conservación, Almacenes y Tecnologías de la Información.
- Seguridad: Personal de seguridad física del establecimiento y enlace con fuerzas de seguridad.
- Comunicaciones: Área de Comunicación Social y enlace institucional con el CVOED.

Cada unidad médica deberá adaptar esta asignación conforme a su estructura, asegurando que las funciones estén claramente designadas y comunicadas a todo el personal.

3.2 Aspectos clave en cada fase

- **Antes:** Análisis estratégico de riesgos, preparación, planificación, directorios y datos de enlaces actualizados de Centros de apoyo especializados (Centros Toxicológicos, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, entre otros.), capacitación, simulacros, inventario de Equipo de Protección Personal (EPP) y antídotos, diseño y puesta a prueba de áreas de descontaminación y seguridad, sistemas de contención y almacenamiento de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), así como áreas de expansión para Incidente intencional con múltiples víctimas (IIMV) y área de cadáveres. Desarrollo del plan de contingencia y tarjetas de acción, activación de los establecimientos de salud de apoyo de la red institucional y las redes Integradas de Servicios de Salud. Contar con claves de acceso a la plataforma CVOED y verificar su correcto funcionamiento. Realizar simulacros para probar el procedimiento operativo, incluyendo entrenamiento en ciberseguridad básica.

- **Durante:** Activación del plan de contingencia, recepción y clasificación de víctimas, descontaminación de los pacientes (en los casos que se requiera y que la condición clínica lo permita), manejo clínico basado en binomios médico-enfermera, protección del personal y la infraestructura, generación de comunicados e informes oficiales para autoridades y población. Implementación del sistema de referencia-contra referencia y censo de pacientes, monitoreo de sistemas digitales para detectar intrusiones.

- **Después:** recuperación progresiva, primeros auxilios psicológicos para el personal operativo, manejo de residuos (ej. agua contaminada, ropa, consumibles, entre otros) y evidencias, generación de informe de cierre de la emergencia, análisis post evento y mejora del plan, evaluación de impactos cibernéticos en datos de pacientes.

3.3 Activación operativa (aplicable a TODOS los escenarios)

Paso 1. Recepción de alerta y verificación

- **Fuente:** CVOED, Protección Civil, establecimientos de salud, fuerzas de seguridad, personal de la salud en el terreno, gobiernos locales y estatales, seguimiento de redes sociales y publicaciones electrónicas de medios oficiales, o arribo espontaneo de forma masiva de víctimas, alertas cibernéticas de CERT-MX.

- **Registrar:** fecha y hora, nombre completo y cargo de quien recibe el alertamiento, de la persona que reporta, tipo de amenaza presunta (explosivo, químico, radiológico-nuclear, tirador activo, combinación), lugar y número estimado de víctimas. Utilice el “notificador de

emergencias" del sistema CVOED, el número telefónico y o mensajería (chat CVOED) explicando la situación.

Regla operativa: En situaciones de alta incertidumbre, la ausencia de información completa no deberá retrasar la activación del Plan de Contingencia. Cuando no se cuente con todos los datos, el establecimiento de salud activará el plan con información mínima disponible, la cual deberá ampliarse y validarse conforme se obtenga nueva información.

Datos críticos mínimos para la activación inicial:

- Tipo de amenaza presunta.
- Lugar del incidente o zona de referencia.
- Número aproximado de víctimas.

Fuente del alertamiento.

- **Comunicar:** utilizar el "notificador de emergencias" del sistema CVOED, el número telefónico y o mensajería (chat CVOED) explicando la situación.

Paso 2. Activación del Plan de Contingencia para Arribo Masivo de Víctimas

- Director(a) del establecimiento de salud o su suplente activa el **Código de emergencia**, por ejemplo, código naranja/plata, de acuerdo con el Plan de Emergencias y Desastres.
- Convoca al **Comité de Emergencias**: activa el SCI-H o cadena de mando, operaciones, logística, finanzas, seguridad, comunicaciones, enlace con autoridades del OOAD.
- Notifica de forma inmediata a través del "notificador de emergencias" del sistema CVOED la activación del plan y si hay información disponible, informa el tipo y magnitud del incidente.
- Movilización de personal de áreas no esenciales a zonas de atención de la emergencia (formación de binomios). Diferimiento de actividades no esenciales para la atención de la emergencia (Cirugía electiva, consulta externa, estudios diagnósticos programados).
- Activación del plan de expansión de capacidades (preparación de áreas de expansión predefinidas, traslados de pacientes convalecientes, altas médicas tempranas).
- Verificar integridad de sistemas digitales (EHR) ante posibles ciberataques asociados.

Paso 3. Seguridad física inmediata

- Seguridad física. Cerrar accesos secundarios; concentrar entrada/salida por puntos controlados. Establecer tamizaje de seguridad en accesos para:
    - Coordinar con policía, guardia nacional o empresa de seguridad, la revisión preventiva de vehículos y paquetes sospechosos (evitar "dispositivos secundarios")
    - Mantener rutas despejadas para ambulancias y vehículos de emergencia
    - Solicitar el apoyo de protección civil y bomberos
- Seguridad clínica (riesgo de contaminación). Identificar de manera temprana pacientes potencialmente contaminados (olores químicos, líquidos, polvos visibles, ropa impregnada).

  - Definir y activar áreas de triage externo y descontaminación cuando sea necesario.
  - Evitar la dispersión de contaminantes dentro del establecimiento y proteger áreas clínicas limpias.
- Seguridad digital básica. Verificar la integridad de los sistemas de información clínica y administrativa.
  - Implementar respaldos offline y aislamiento de redes ante sospecha de ciber incidente asociado.
  - Mantener comunicación con las instancias institucionales de soporte tecnológico.

Paso 4. Activar, señalizar y comunicar:

- Área de triage externo (si es seguro):
  - Triage rápido de todas las víctimas que llegan.
  - Separar “sospecha de contaminación” de “no contaminados”.
  - Integrar telemedicina segura para consultas remotas si el incidente afecta accesos físicos.
  - En pacientes con riesgo vital inmediato, se priorizarán las maniobras que salvan la vida antes de completar la descontaminación, siempre que el riesgo para el personal sea considerado aceptable y se cuente con el equipo de protección personal disponible. Esta decisión deberá sustentarse en criterios clínicos y de seguridad, y no deberá retrasar intervenciones críticas como el control de hemorragias, el aseguramiento de la vía aérea o la ventilación.
  -

- **Corredor de descontaminación** (si procede: químico/agente radiactivo):
  - Preferiblemente fuera del edificio principal (carpas, zona de ambulancias) con entrada y salida claramente diferenciadas.
  - Gestionar adecuadamente ropa y material contaminado, así como el agua contaminada, cuando sea posible.

- **Áreas clínicas limpias:**
  - Urgencias, reanimación, quirófanos, UCI, hospitalización.
  - Delimitar las áreas para la atención y tránsito de pacientes, cubriendo si es posible pisos y equipos con plástico o papel estraza para disminuir el riesgo de contaminación.
  - Flujo unidireccional: a) triaje, b) descontaminación, c) tratamiento; nunca al revés. No se pierda en establecer otros diagnósticos complejos.
  - Una sola ruta contaminada, evite la dispersión, aísle las áreas de trabajo.

- Retirar al personal no esencial, familiares y otros pacientes de las áreas de atención de las víctimas de la emergencia.

- **Noria de ambulancias:** establezca un circuito unidireccional para el acceso de ambulancias y vehículos que trasladen lesionados, para facilitar la gestión de ingresos y traslados hacia otros establecimientos de salud. Considera una zona de descontaminación de ambulancias en caso de ser requerido.

Paso 5. Triage y manejo inicial

Cada establecimiento de salud debe utilizar el sistema de triage para incidentes con múltiples víctimas adoptado institucionalmente, tanto en el área de urgencias y en caso necesario en el área de descontaminación, previo a su ingreso a la unidad, de forma ética.

- Aplicar sistema de triage institucional
- Active el código negro para la disposición de cadáveres (considere el riesgo de contaminación interna y externa).
- Priorizar intervenciones que salvan vidas en minutos:
  - Control de hemorragia (torniquetes, apósitos hemostáticos).
  - Apertura, aseguramiento de vía aérea
  - Ventilación básica, descompresión torácica cuando esté indicado.
  - Antídotos inmediatos (p.ej. síndrome colinérgico) según protocolos.
  - En paciente obstétrica grave activar código ERI, priorizando la vida materna.
  - Estabilización y traslado de los pacientes al área de atención definitiva (hospitalización, quirófano, terapia intensiva, egreso).
  - Considerar triage psicosocial rápido para identificar trauma agudo.

Paso 6. Comunicación interna y externa

- Mensajes breves, claros, precisos:
  - A personal (altavoces, SMS, mensajería segura).
  - A establecimientos de salud de referencia y red integrada de servicios de salud (Notificador de emergencias y mensajero del sistema CVOED).
  - A medios: deberá centralizarse en un vocero institucional designado, a fin de garantizar la emisión de mensajes oficiales claros, consistentes y oportunos. .Usar canales cifrados para evitar intercepciones en eventos intencionales. El personal del establecimiento deberá abstenerse de difundir información, imágenes o videos relacionados con el evento a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o medios no oficiales, salvo autorización expresa de la instancia institucional competente.

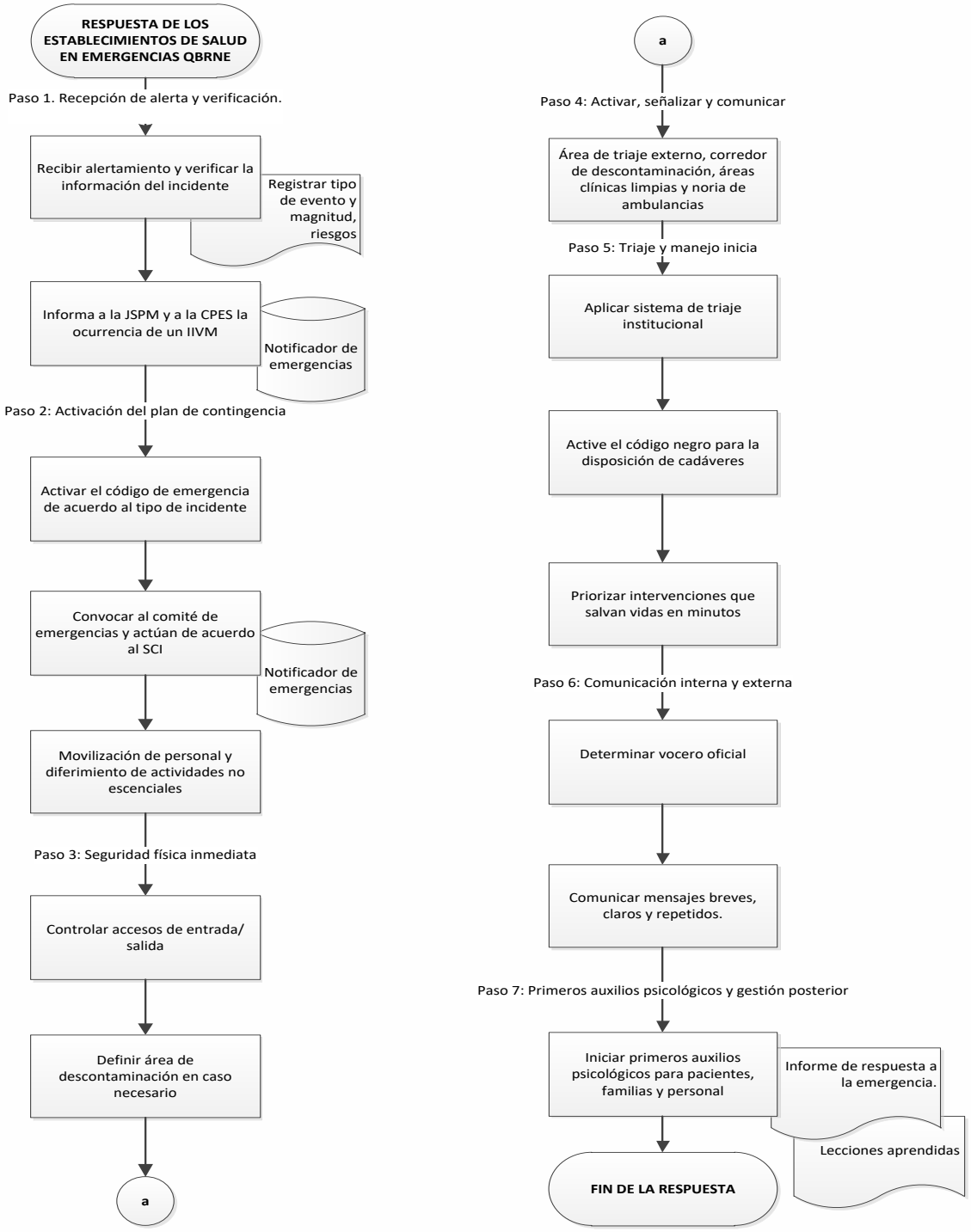
- El establecimiento de salud deberá realizar un monitoreo básico de medios y redes sociales para identificar información falsa, imprecisa o que pueda generar pánico, coordinando su atención a través de los canales institucionales correspondientes.

Paso 7. Primeros auxilios psicológicos y gestión posterior

- Iniciar primeros auxilios psicológicos para pacientes, familias y personal, otorgados por personal capacitado.
- Documentar la respuesta, recopilar datos clínicos y operativos, y elaborar informe de lecciones aprendidas.
- Brindar herramientas emocionales y cognitivas que permitan la recuperación y restablecimiento de una vida funcional.
- Ofrecer un enfoque multidisciplinario que incluye grupos de apoyo, intervención familiar e incluso con otros profesionales de la salud.
- Incluir ejercicios de retroalimentación obligatorios posterior al evento.

4. Anexos

Anexo 1. Diagrama de flujo de la activación operativa (aplicable a todos los escenarios)

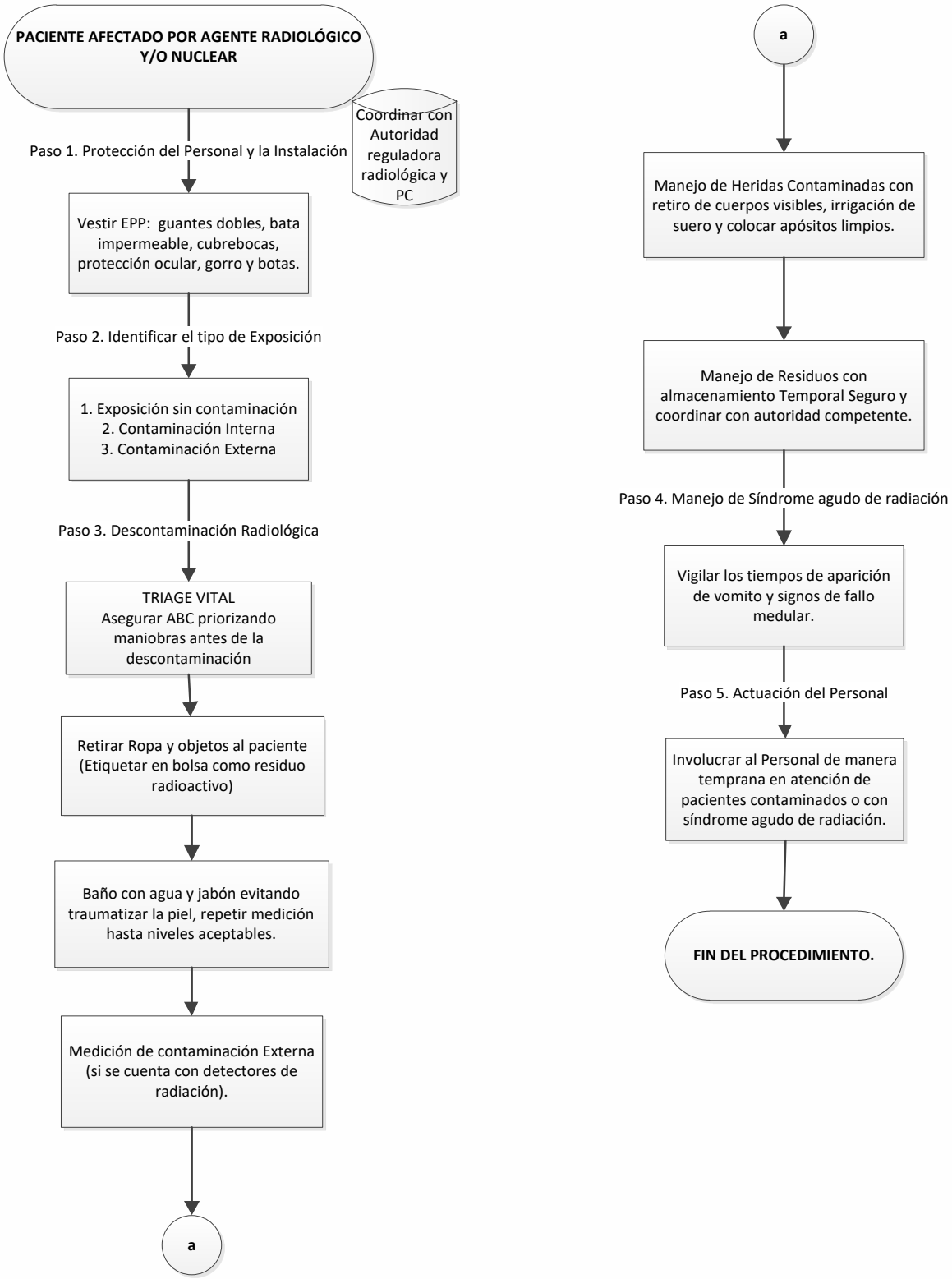


Anexo 2. Pacientes afectados por agentes químicos

Objetivos operativos	1. Proteger al personal, a la infraestructura y al medio ambiente frente a la contaminación. 2. Descontaminar de forma rápida y segura, retiro completo de la ropa de los pacientes con adecuado manejo de RPBI. 3. Tratar de forma precoz y sindrómica a las víctimas (antes de que se identifique el agente específico
Identificación rápida de un evento químico	Sospechar evento químico intencional cuando: • Llegan múltiples pacientes con inicio súbito de síntomas similares (p.ej. miosis, salivación, convulsiones; disnea súbita; irritación intensa de ojos y vías aéreas). • Relatos de “gas”, “niebla”, “olor fuerte” (cloro, almendras, ajo, solventes). • Ropa visiblemente húmeda, con residuos o cristales. • Animales muertos en el sitio del evento (referido por primer equipo de respuesta).
Protección del personal y del hospital	Limitar el contacto directo con pacientes potencialmente contaminados a personal entrenado y equipado con: • EPP nivel C como mínimo: overol impermeable, guantes dobles, botas, protección ocular y respiratoria (respirador con filtro adecuado), según fichas de seguridad del agente. • Cerrar tomas de aire exterior y, si es posible, detener temporalmente el sistema de aire acondicionado central para evitar ingreso de vapores al interior. • Definir área de descontaminación fuera de la zona de urgencias (idealmente al aire libre, con drenaje controlado).
Descontaminación masiva	Principios: • Quitar la ropa elimina hasta 80 - 90 % de la contaminación en muchos escenarios. • Priorizar intervenciones que salvan la vida antes de la ducha si el riesgo para el personal es aceptable (vía aérea, antídotos). • Hay que considerar que en algunos casos los pacientes fueron descontaminados en la zona del evento por lo que podría priorizarse la atención médica en la unidad, sin embargo el personal debe contar con EPP para este proceso. Procedimiento básico: 1. Pre descontaminación (zona tibia):

	• Triage rápido: ambulante vs no ambulante. • Entregar instrucciones simples: “Retire toda su ropa, póngala en esta bolsa marcada, siga hacia las duchas”. 2. Retiro de ropa: • Ropa en bolsas herméticas etiquetadas (hora, lugar, paciente); manejar como residuo químico y posible evidencia. 3. Ducha: • Uso de agua tibia y jabón neutro, de cabeza a pies, evitando hipotermia (cobijas, láminas térmicas). • Cuidar la intimidad (cortinas, circuitos separados por sexo, apoyo a grupos vulnerables). 4. Pos Descontaminación: • Entrega de ropa limpia desechable. • Nuevo triage clínico en área limpia, antes de entrar a urgencias.
Manejo clínico inicial (sin entrar a dosificaciones y basados en evidencia)	**Síndrome colinérgico** (posibles agentes nerviosos / organofosforados): • Signos: miosis intensa, broncorrea, bradicardia, convulsiones. • Medidas iniciales: oxígeno, aspiración de secreciones, soporte ventilatorio; administrar atropina + reactivador de colinesterasa; benzodiacepina para convulsiones. **Agentes asfixiantes (cloro, fosgeno):** • Oxígeno suplementario, broncodilatadores, monitorización y manejo de edema pulmonar. **Agentes irritantes / corrosivos:** • Lavado copioso de piel y mucosas (incluyendo irrigación ocular). • Manejo de quemaduras químicas según protocolos de quemados.

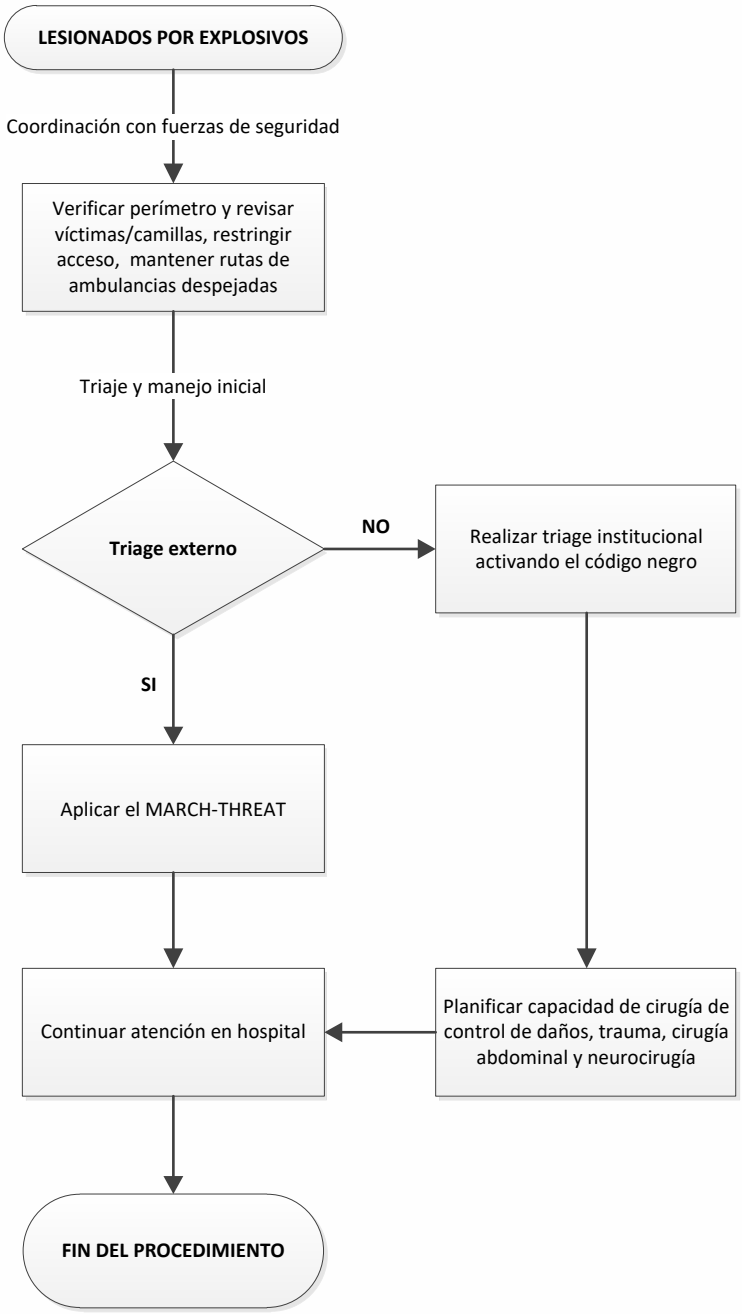
Flujograma del anexo 3. Pacientes afectados por agentes radiológicos / nucleares



Anexo 4. Lesionados por explosivos

Objetivos operativos	1. Recibir y clasificar rápidamente víctimas de explosiones intencionales. 2. Identificar y tratar precozmente lesiones típicas por onda expansiva. 3. Proteger al hospital de explosivos secundarios y saturación de servicios.
Seguridad y recepción	Coordinar con fuerzas de seguridad para: • Protección en la periferia del establecimiento de salud. • Revisión visual básica de víctimas y camillas ante posible presencia de artefactos no detonados. • Control de acceso de paquetes y mochilas a urgencias. • Actuación por un posible ingreso de personas armadas. • Mantener rutas vehiculares de ambulancias despejadas para entrada y salida.
Triaje y manejo inicial	En área de triaje externo aplicar la metodología THREAT: • T (Threat suppression /supresión de amenazas): asegurar que no haya amenaza activa en el entorno inmediato. • H (Hemorragia): control inmediato de sangrados con torniquetes, compresión y agentes hemostáticos. • R/A (Respiración / vía aérea): apertura de vía aérea, ventilación, descompresión torácica cuando proceda. • E/T (Evacuación / Transporte): organización de traslado a reanimación, quirófano o derivación.
Lesiones típicas por explosión	• Lesión primaria: daño por onda de presión (pulmón, oído, intestino). • Lesión secundaria: fragmentos del artefacto u objetos proyectados. • Lesión terciaria: proyección del cuerpo (trauma cerrado, fracturas). • Lesión cuaternaria: quemaduras, inhalación de humo, intoxicaciones.
Consideraciones clínicas	Planificar capacidad de: • Cirugía de control de daños. • Manejo de lesión torácica y abdominal por explosión. • Neurocirugía y cirugía ortopédica para trauma complejo. • Soporte respiratorio para neumotórax, hemotórax y contusión pulmonar.

Flujograma del anexo 4. Lesionados por explosivos



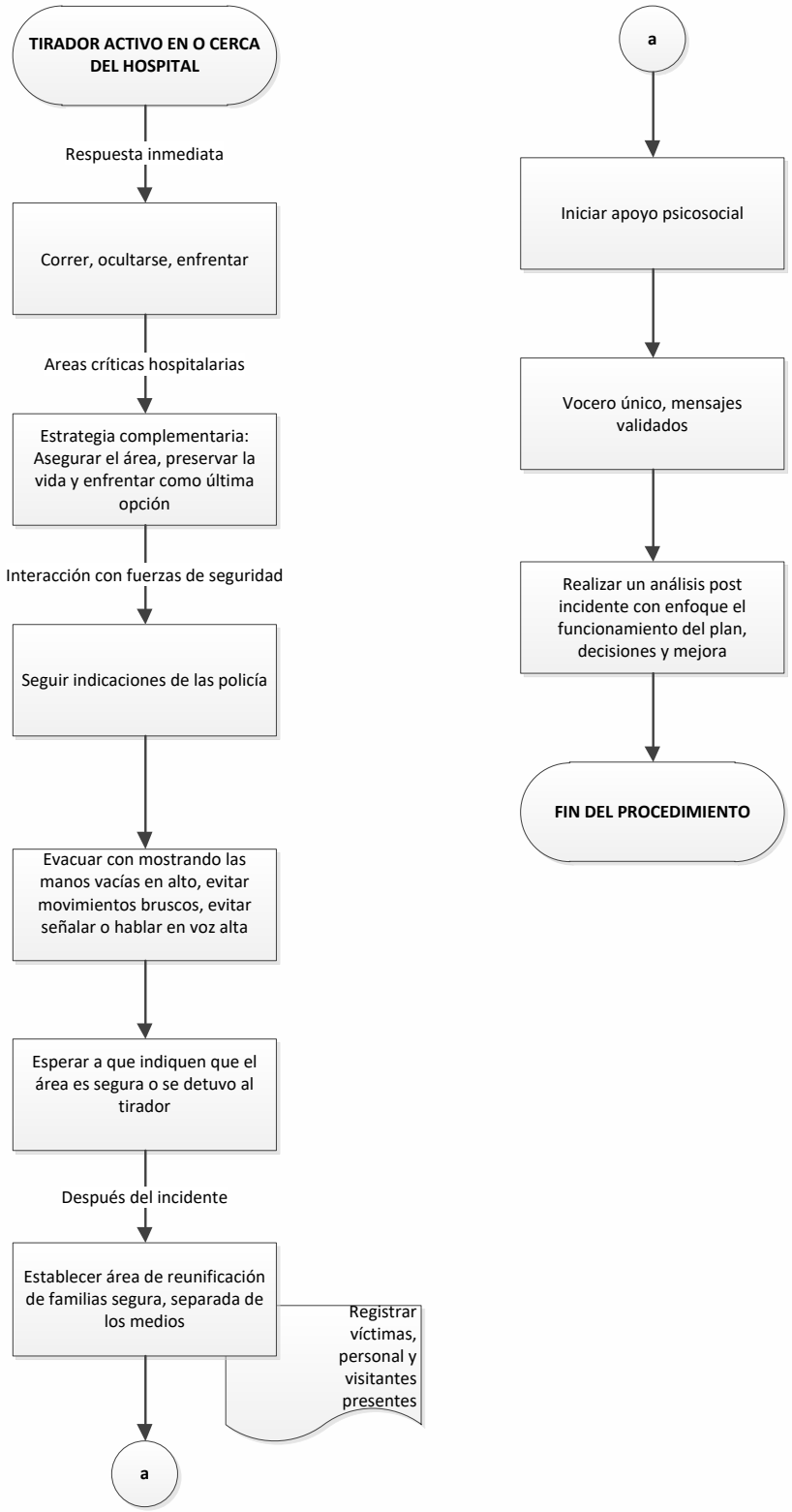
Anexo 5. Tirador activo (Active Shooter) en o cerca del hospital

Principios específicos	1. El personal del establecimiento no deberá intentar verificar la amenaza, localizar al agresor ni desplazarse hacia el área donde se presume la presencia de un tirador activo, ya que estas acciones incrementan significativamente el riesgo de lesiones o muerte. 2. La respuesta del personal deberá limitarse a la protección de su integridad y la de los pacientes, siguiendo los principios establecidos en este protocolo y las indicaciones de las fuerzas de seguridad. 3. El tirador activo suele actuar de forma rápida e impredecible; muchos eventos terminan antes de que lleguen las primeras unidades de policía. 4. Si el tirador activo se encuentra en la unidad médica, la estrategia general a aplicar en las áreas será Correr – Esconderse – Pelear (Run–Hide–Fight) debe complementarse para áreas con pacientes críticos que no pueden ser movilizados y/o evacuados (UCI, quirófanos) con Asegurar, Preservar, Luchar (Secure–Preserve–Fight) 5. La prioridad de las fuerzas de seguridad será neutralizar la amenaza, no atender víctimas inicialmente.
Preparación previa	Incluir un Anexo de Tirador Activo en el Plan Hospitalario de Emergencias, siguiendo estructura de amenazas específicas. Realizar evaluación de riesgos de seguridad: • Entradas/salidas, puertas que puedan cerrarse/atrancarse, zonas de refugio (“safe rooms”), rutas de evacuación principales y alternas. • Establecer un código interno de tirador activo con lenguaje claro (p.ej.: “Atención, tirador activo en [lugar]. Active protocolo de seguridad ahora”). Capacitar a todo el personal en: • Correr-Ocultarse-Enfrentarse (Run-Hide-Fight) y su aplicación en diferentes áreas. • Procedimientos específicos de su servicio (quirófano, UCI, urgencias). Coordinar y realizar simulacros conjuntos con policía, bomberos y sistema de emergencias médicas.

Respuesta inmediata (Run–Hide–Fight)	1. Correr (Run) / evacuar • Opción preferente para quienes puedan salir de forma segura: • Abandonar el área o el edificio, dejar pertenencias. • Ayudar a pacientes ambulatorios a evacuar si es seguro. • No utilizar elevadores; usar escaleras si es seguro. 2. Ocultarse (Hide) • Cuando evacuar no es posible salga de la vista del agresor: • Entrar a una habitación, cerrar y atrancar la puerta (mobiliario pesado, dispositivos de bloqueo). • Apagar luces, silenciar teléfonos y radios, alejarse de puertas y ventanas. • Procurar ocultarse en la pared lateral a la puerta, fuera de la línea de tiro. 3. Enfrentar (Fight) -como último recurso- Sólo cuando la vida está en peligro y no existe otra opción: • Atacar de forma decidida, en grupo si es posible. • Utilizar objetos disponibles (extintores, sillas, instrumentos) para desarmar o incapacitar al atacante.
Estrategia complementaria en áreas con pacientes críticos: Secure–Preserve–Fight	Para personal en quirófanos, UCI u otras áreas donde evacuar implica alto riesgo de muerte para los pacientes: 1. Asegurar el área (Secure) • Cerrar y bloquear todas las puertas de acceso. • Apagar luces innecesarias, silenciar equipos no críticos. • Alejarse de puertas y ventanas con los pacientes tanto como sea posible. 2. Preservar la vida (Preserve) • Continuar únicamente las maniobras esenciales de soporte vital: ▪ En cirugía, aplicar principios de “cirugía de control de daños” y cerrar en cuanto sea seguro. ▪ Suspender procedimientos electivos y diagnósticos no urgentes. ▪ Proteger a los pacientes con barreras improvisadas si procede. 3. Enfrentar (Fight) • Sólo como último recurso si el atacante intenta ingresar al área asegurada.

Interacción con fuerzas de seguridad	• Esperar que los primeros policías ingresen rápidamente, en formación, sin detenerse a atender heridos. • El Personal debe: ▪ Evacuar mostrando las manos vacías en alto, evitar movimientos bruscos, evitar señalar o hablar en voz alta ▪ Obedecer a la policía. ▪ Seguir instrucciones (p. ej., tirarse al suelo, manos en la cabeza). ▪ No correr hacia los agentes ni sujetarlos. ▪ Esperar a que indiquen que el área es segura o se detuvo al tirador.
Después del incidente	• Establecer área de reunificación de familias segura, separada de los medios. • Registrar víctimas, personal y visitantes presentes. • Implementar: ▪ Apoyo psicosocial de corto y largo plazo para víctimas, familiares y personal. ▪ Estrategia de comunicación con medios (vocero único, mensajes validados). • Realizar un análisis post incidente con enfoque en: ▪ Funcionamiento del plan. ▪ Decisiones éticas (protección de pacientes vs seguridad personal). ▪ Necesidades de mejora en infraestructura, entrenamiento y protocolos.

Flujograma del anexo 5. Tirador activo (Active Shooter) en o cerca del hospital



Referencias

1. World Health Organization. Guide Mass casualty preparedness and response in emergency units. (2022). Disponible en: https://storage.googleapis.com/ncds-emergencies-2024-source/Background%20documents/Mass%20casualty%20preparedness%20and%20response%20in%20emergency%20units.%20Guide.%20Version%2020220501.pdf
2. Organismo Internacional de Energía Atómica. (2007). Manual para primeros actuantes ante emergencias radiológicas. International Atomic Energy Agency. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/EPR_Frist%20Responder_S_web.pdf
3. Gobierno de México. (2024). Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2024, Equipo de protección personal: Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/9496/stps/stps.html
4. Giwa AO, Milsten A, Vieira DL, Ogedegbe C, Kelly KM, Schwab AP, Moskop JC. "Run, Hide, Fight," or "Secure, Preserve, Fight": How Should Health Care Professionals and Facilities Respond to Active Shooter Incidents? Acad Emerg Med. 2020 Mar;27(3):252-255. doi: 10.1111/acem.13912
5. Federal Emergency Management Agency (FEMA). Nuclear detonation response guidance: Planning for the first 72 hours. 2023. Disponible en: https://remm.hhs.gov/fema_oet-72-hour-nuclear-detonation-response-guidance.pdf
6. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Preparación y respuesta para casos de emergencia nuclear o radiológica. Requisitos de Seguridad Generales, Parte 7. Viena: OIEA; 2018. Disponible en: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1708S_web.pdf
7. Vázquez MA, Pérez MR. Guía para la respuesta médica en la fase inicial de una emergencia radiológica. Buenos Aires: Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina; 2007. Disponible en: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/38/058/38058887.pdf?r=1&r=1
8. Goans RE, Waselenko JK. Medical management of radiological casualties. Health Phys. 2005;89(5):505-12. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16217194/
9. Baloian I, Chia E, Cornejo C, Paverini C. Intervención psicosocial en situaciones de emergencia y desastres: Guía para el primer apoyo psicológico. Santiago de Chile: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile; 2007. Disponible en: https://www.cop.es/uploads/PDF/GUIA-INTERVENCION SITUACIONES-EMERGENCIA.pdf
10. Martín MS. Triage en situaciones de desastre. Cir Gen. 2010;32(1):S33–S36. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2010/cge101m.pdf
11. Alcázar Fernández M. Plan de emergencia interior de la instalación radiactiva de la Universidad de Murcia. Murcia: Universidad de Murcia; 2018. Disponible en: https://www.um.es/documents/1765772/11223097/PEI%20rev4_2018.pdf/dbcefe04-2a02-44e3-a26e-6a5dae040a06

12. Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Seminario de respuesta a emergencias radiológicas. Ciudad de México: CNSNS; 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269248/4._Repuesta_a_emergencia_radiol_gicas.pdf
13. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Manual para primeros actuantes en emergencias radiológicas. Viena: OIEA; 2006. Disponible en: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/EPR_FirstResponder_web.pdf
14. Is tactical combat casualty care in terrorist attacks suitable for civilian first responders?. Borgers F, Van Boxstael S, Sabbe M.J Trauma Acute Care Surg. 2021 Oct 1;91(4):e86-e92. doi: 10.1097/TA.0000000000003337.PMID: 34238863 Review.
15. Learning From Simulating Mass Casualty Events: A Systematic Search and a Comprehensive Qualitative Review. Ledbury K, Glasgow S, Tallach R.Disaster Med Public Health Prep. 2022 Oct 14;17:e242. doi: 10.1017/dmp.2022.205.PMID: 36238998 Review.
16. Mass Casualty Management After a Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion in an Urban Area.Gamberini L, Imbriaco G, Flauto A, Monesi A, Mazzoli CA, Lupi C, Costa DMR, Mora F, Dell'Arciprete O, Cordenons F, Picoco C, Gordini G.J Emerg Med. 2021 Apr;60(4):471-477. doi: 10.1016/j.jemermed.2020.11.029. Epub 2021 Jan 7.PMID: 33422372
17. WHO. Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks. 2023.

Recursos

Curso: Sistema de Comando de Incidentes para Hospitales (SCI-H). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/sistema-de-comando-de-incidentes-para-establecimientos de salud.

Curso: Marco de respuesta multiamenaza: Planeamiento hospitalario para la respuesta a emergencias en salud y desastres. Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/respuesta-multiamenaza-planeamiento-hospitalario-emergencias

Curso: Curso virtual de evaluación de establecimientos de salud a través del índice de seguridad hospitalaria (ISHv2). Campus Virtual de Salud Pública. OPS. disponible en: https://campus.paho.org/es/curso/evaluacion-de-establecimientos-de-salud

Curso FEMA: Active Shooter Preparedness (IS-907). Dispoible en: https://training.fema.gov/is/courseoverview.aspx?code=IS-907

Contacto

Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED)
(24/7 los 365 días del año)
Teléfonos:
55 52 62 53 68 (directo)
55 52 38 27 00 (conmutador), Extensiones: 19081, 19083, 10315, 19832 y 19831
55 80 03 58 24 (WhatsApp)
Sitio web: https://cvoed.imss.gob.mx
Correo electrónico: cvoed.coord@imss.gob.mx

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)
55 5095 3200 línea nacional para reportes relacionados con fuentes radiactivas robadas o emergencias radiológicas.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
55 11 03 60 00 ext. 72034

Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil / Sistema Nacional de Protección Civil (CENACOM), 24 horas 365 días del año
51 28 00 00 ext. 36422 y 36428